CIRUGÍA MENOR Y AMBULATORIA

DR. GERARDO VICTORIA

DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Cirugía ambulatoria: el paciente ingresa y egresa el mismo día, sin pernoctar en el hospital.
- Candidatos ideales: ASA I-II, bajo riesgo de sangrado y duración menor a 90 minutos.
- Requiere un acompañante responsable y buen soporte en casa durante las primeras 24 horas.

	DEFINICIÓN	EJEMPLOS
ASA I	Paciente sano	Sano, no fumador, consumo mínimo o ninguno de alcohol
ASA II	Paciente con enfermedad sistémica moderada	Fumador, embarazo, IMC 30-40, DM2 o HAS controlada, sin limitaciones funcionales
ASA III	Paciente con enfermedad sistémica severa	Limitación funcional importante, DM2 o HAS descontroladas, EPOC, IMC >40, hepatitis activa, abuso de alcohol, marcapasos, ERC bajo diálisis, IAM, AIT, EVC, EAC <3 meses
ASA IV	Paciente con enfermedad sistémica severa	IAM, AIT, EVC, EAC <3 meses, disfunción valvular severa, reducción importante de Fracción de eyección, sepsis, CID, SDRA, ERC terminal sin diálisis
ASA V	Paciente moribundo cuya supervivencia es nula si no se realiza la cirugía	Aneurisma abdominal/torácico roto, trauma masivo, hemorragia intracraneal con efecto de masa, intestino isquémico con falla cardiaca o disfunción orgánica múltiple
ASA VI	Paciente declarado muerte cerebral, soporte vital para procuración de órganos	

PROCEDIMIENTOS COMUNES

- Hernioplastias, exéresis de lipomas y quistes, biopsias de piel y mama.
- Procedimientos endoscópicos diagnósticos.
- Cirugía laparoscópica menor, como la colecistectomía en casos seleccionados.



COMPLICACIONES Y SEGUIMIENTO

- Son poco frecuentes: dolor no controlado, sangrado menor o infección de la herida.
- Se entrega un número de contacto y los signos de alarma por los que el paciente debe volver a consulta.

CRITERIOS DE ALTA

- Signos vitales estables durante al menos 30 minutos.
- Dolor controlado con analgesia oral.
- Tolera líquidos o alimentos por vía oral.
- Puede caminar y orinar sin asistencia (según el procedimiento).
- Sale acompañado de un adulto responsable, con instrucciones por escrito.

ANESTESIA EN CIRUGÍA AMBULATORIA

- Anestesia local o regional: preferida cuando es posible, acelera la recuperación y el egreso.
- Anestesia general de corta duración: también se usa en procedimientos seleccionados.

VENTAJAS DE LA CIRUGÍA AMBULATORIA

- Menor costo que la hospitalización convencional.
- Menor riesgo de infecciones intrahospitalarias.
- Recuperación más rápida en el entorno familiar.
- Libera camas hospitalarias para casos más complejos.

